CAPÍTULO 159

ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE SUMISIÓN QUÍMICA

Cesáreo Fernández Alonso | Andrés Santiago Sáez

1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS

El término *sumisión química* (SQ) proviene del francés *soumission chimique* y se define como la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento con el fin de provocar una modificación en su grado de vigilancia, su estado de consciencia o su capacidad de juicio. En países anglosajones, a la SQ se la conoce como *drug-facilitated crimes* o *Drug-Facilitated Sexual Assault* (DFSA) cuando se asocia a agresión sexual.

Desde un punto de vista práctico se reconocen dos supuestos:

1. Caso de probable SQ premeditada o proactiva: se produce administración subrepticia de alguna sustancia, con frecuencia asociado a bebidas alcohólicas, con intencionalidad delictiva.
2. Caso de probable SQ oportunista o vulnerabilidad química (VQ): tipo de delito, habitualmente robo y/o agresión sexual, facilitado por el consumo voluntario de tóxicos por parte de la víctima.

2. TÓXICOS EN LA SUMISIÓN QUÍMICA

Las sustancias empleadas en la SQ reúnen una serie de características comunes:

- Son fáciles de obtener, de forma legal o ilegal (a través de internet).
- Suelen ser sustancias sin sabor, color ni olor, administradas habitualmente v.o. junto con bebidas alcohólicas. Excepcionalmente se han detectado otras vías, como la inhalada o la transdérmica.
- Son activas a dosis bajas, de acción rápida y de corta duración.
- Tienen acción depresora o estimulante del sistema nervioso central (SNC).
- Ocasionan amnesia anterógrada, sedación, confusión, efecto alucinógeno o desinhibición.

Se han descrito más de 30 sustancias implicadas en casos de SQ. Las más habituales son:

- Alcohol etílico: es la sustancia que más frecuentemente se asocia a sospecha de SQ. Presenta la capacidad de alterar el juicio y reducir las inhibiciones y en grandes dosis puede producir la pérdida del control corporal y de la consciencia. La víctima suele consumir de forma voluntaria bebidas alcohólicas, asociado o no a otros tóxicos, de forma voluntaria o involuntaria.
- Benzodiazepínicos: son los fármacos más frecuentemente detectados en casos de SQ. Entre sus efectos secundarios hay que mencionar el automatismo, la desinhibición y la amnesia anterógrada. Se utilizan principalmente los que poseen una cinética de distribución y eliminación rápida, como triazolam, oxazepam y flunitrazepam (en desuso en los últimos años).
- Otros psicofármacos: se han detectado hipnóticos no benzodiazepínicos, como zolpidem y zopiclona, antidepresivos, barbitúricos o neurolépticos.

Entre las drogas de abuso y sustancias emergentes se han identificado muchas, como cocaína, 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), tenamfetamina (MDEA), 3,4-metilendioxietilamfetamina

(MDA), dietilamina de ácido lisérgico (LSD), gammahidroxibutirato (GHB) o éxtasis líquido, *popper*, cannabis y derivados (ver el capítulo 155).

Otras drogas que también se están utilizando en la SQ son:

- Ketamina: anestésico comercializado en forma de vial para su administración parenteral. Como droga de abuso, se deseca al horno, microondas o a fuego lento, convirtiéndola en polvo, que se consume v.o., fumado o esnifado. Combina efectos hipnóticos, alucinógenos, amnésicos y de despersonalización, sin pérdida de consciencia ni depresión respiratoria a bajas dosis.
- Escopolamina, burundanga o hioscina: alcaloide antimuscarínico que se encuentra como metabolito secundario en plantas de la familia de las solanáceas, estramonio, escopolia o mandrágora, entre otras. *Burundanga* es una palabra afrocubana que hace referencia a un brebaje hecho con arbustos o plantas que contienen escopolamina. Se la conoce también como *beso del sueño*, *polvo zombi* o *aliento del diablo*. Puede administrarse tanto v.o. como por vía cutánea. Actúa con rapidez ocasionando depresión del SNC y efecto anticolinérgico. Se trata de una sustancia muy popular rodeada de mitos. Recientemente se han notificado los primeros casos de SQ por burundanga. Para su tratamiento se necesitan laboratorios cualificados y que la víctima acuda precozmente a Urgencias.
- *Research Chemicals* (RC): sustancias químicas también denominadas *legal highs* o *nuevas sustancias de síntesis* que en realidad fueron sintetizadas hace más de 30 años o son antiguos fármacos o derivados utilizados con fines recreativos con efectos preferentes en el SNC, de acciones muy parecidas a las de las anfetaminas o la cocaína. Un ejemplo de RC asociado a sospecha de SQ es la alfapirrolidinovaleroferona (α-PVP) o *flakka*. Se trata de una sustancia que pertenece al grupo de las catinonas sintéticas, derivada del prolintano, vendida sin receta como complejo vitamínico hace décadas, actualmente retirada del mercado, que a su vez se asemeja a la metilendioxipirovalerona (MDPV) o droga caníbal. Se encuentra como pastillas de *flakka* en forma de polvo para ser esnifado y se vende como inofensivas “sales de baño”.

3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

A continuación se resumen los aspectos más relevantes del procedimiento de actuación ante sospecha de SQ en el Servicio de Urgencias hospitalario (SUH).

3.1. ACOGIDA DEL PACIENTE

La sospecha de SQ debería comenzar en la valoración inicial del paciente en el triaje de Urgencias. En casos de pacientes con consumo perjudicial de tóxicos y/o alteración del nivel de consciencia se debería preguntar al paciente y/o al acompañante si es posible que “alguien le haya administrado alguna sustancia y/o le ha sucedido algo que pueda ser delito sin su consentimiento”.

La sospecha de SQ lleva asociada la de posible agresión sexual. Se ha descrito que al menos una de cada tres agresiones sexuales es facilitada por tóxicos. Los principales motivos o situaciones referidos por la víctima que suscitan una posible agresión sexual son: recordar o tener la sensación de haber sido víctima de una agresión sexual, despertarse desnuda o con la ropa desarreglada, encontrar en su cuerpo fluidos (semen..) u objetos (preservativos..) inexplicados, presentar lesiones o alteraciones inexplicadas a nivel oral, anal o genital, despertarse con un desconocido al lado o en un lugar extraño o haber explicado que se encontraba en una situación extraña o comprometedora.

3.2. HISTORIA CLÍNICA

Se recomienda una anamnesis dirigida. Debe comenzarse preguntando el motivo de consulta, los síntomas que presenta y si sospecha que ha sido víctima de un delito. Es necesario indagar

y documentar el consumo voluntario de medicamentos de cualquier tipo y de sustancias tóxicas como alcohol y/o drogas, cantidad y momento del consumo. En todos los síntomas es muy importante detallar la secuencia temporal: cuándo aparecieron, cuánto han durado y si están presentes en el momento de la entrevista.

Los principales síntomas asociados a la sospecha de SQ son amnesia completa o parcial, alteración del comportamiento o la conducta, confusión, somnolencia, agitación o alucinaciones, desinhibición, mareo, resaca desproporcionada o pérdida del conocimiento.

Es indispensable realizar una exploración física sistemática y por aparatos en presencia de testigos (al menos un profesional del ámbito sanitario, que conviene que sea del mismo sexo del paciente; si el paciente lo desea, estará también presente un acompañante).

Se describirán todas las lesiones encontradas, siendo recomendable dibujarlas en un boceto del cuerpo, detallando su tamaño, localización y aspecto. En el caso de los hematomas, si es posible, hay que decir el tiempo de evolución en función de sus características. Hay que poner especial cuidado durante la exploración física para no alterar la recogida de muestras posterior.

Ante la sospecha de agresión sexual se requiere una exploración física dirigida al área urogenital o ginecológica, con recogida de muestras en presencia del médico forense, sobre todo en las primeras 72 h. Es posible que la víctima tenga que ser traslada a otro hospital para su valoración médico-forense tras contactar con la Policía y/o Juzgado de guardia.

3.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS GENERALES

Se incluyen todas las pruebas necesarias disponibles en el SUH (análisis de laboratorio, electrocardiograma [ECG] o pruebas radiológicas) que sean necesarias para el diagnóstico de los problemas clínicos actuales y sus consecuencias.

Se valorará la necesidad de solicitar análisis de tóxicos al laboratorio de Urgencias siguiendo las indicaciones habituales, sobre todo diagnóstico diferencial, recordando que no sustituye a la recogida de muestras bajo cadena de custodia. Muchas de las sustancias reconocidas en casos de SQ no pueden ser detectadas de forma rutinaria en los SUH. Las sustancias empleadas para la SQ son muy heterogéneas y con frecuencia indetectables por administrarse a concentraciones muy bajas o por no disponer de medios adecuados para su detección.

3.4. MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA SU ANÁLISIS TOXICOLÓGICO-FORENSE

Siguiendo las instrucciones de actuación publicadas por el Ministerio de Justicia recogidas en guías clínicas de actuación en el ámbito hospitalario, se recomienda recoger por su utilidad las muestras biológicas que se detallan a continuación.

3.4.1. Sangre

Se recomienda la extracción de sangre venosa periférica en 2 tubos de 5 ml, uno con fluoruro sódico como conservante y oxalato potásico como anticoagulante y otro con sangre total anticoagulada con etilendiaminotetracético (EDTA) para evitar la formación *in vitro* de GHB, procurando llenarlos al máximo para evitar, en la medida de lo posible, la cámara de aire. Deben almacenarse y enviarse en condiciones de refrigeración (2-8 ºC).

La sangre es una muestra biológica que informa del consumo reciente de la sustancia y además puede permitir establecer la correlación entre la concentración y el efecto clínico. Como principal desventaja de su uso para este tipo de casos figura la rápida eliminación de las sustancias de este medio biológico, por lo que en el caso de existir cierto retraso en solicitar ayuda médica, es pro-

bable que la sustancia administrada haya desaparecido de la sangre. Por ello no se recomienda esta prueba si han pasado más de 48 h desde el presunto acto delictivo.

3.4.2. Orina

Se recomienda recoger toda la que se pueda en un frasco de seguridad de 50 ml, que también debe almacenarse en condiciones de refrigeración (2-8 ºC).

La orina es una muestra que también informa del consumo reciente. Ofrece ventanas de detección superiores a las de la sangre para las sustancias químicas, ya que pueden llegar a ser de varios días, como en los cannabinoides y metabolitos de algunas benzodiazepinas. Por ello se recomienda su recogida hasta pasados 7 días. En la tabla 1 se recoge la ventana de detección estimada en las drogas habituales.

Tabla 1. Tiempo de detección de tóxicos

TÓXICO	TIEMPO DE DETECCIÓN ESTIMADO	
	Sangre	Orina
Etanol	2-14 h	3-5 días
Escopolamina*	2-6 h	2-6 h
GHB*	0,3-1 h	< 12 h
Benzodiazepinas	6 h-3 días	3-30 días
Opioides	8-12 h	1-4 días
Barbitúricos	1-3 días	2-4 días
Ketamina*	2-4 h	3-7 días
Cocaína y metabolitos	1-2 días	2-4 días
Anfetaminas y derivados	12 h-3 días	1-6 días
LSD*	2-3 h	1-3 días
MDMA*	1-2 días	3-4 días
Cannabis y derivados (THC)	20 h-14 días	- 30 días

* No disponible en análisis rutinarios en Urgencias.
GHB: gammahidroxibutirato; LSD: dietilamina de ácido lisérgico; MDMA: 3,4-metilendioximetanfetamina; THC: tetrahidrocannabinol.

3.4.3. Cabello

Sirve para distinguir la exposición única de la crónica y para poner en evidencia el tóxico que ya ha desaparecido de la sangre y la orina. La recogida de cabello solo se contempla a petición o mediante extracción por parte del médico forense. Se deben obtener 2 mechones de pelo del grosor de un lápiz de la nuca, cortados a ras del cuero cabelludo, y enviarse en un sobre de papel, indicando cuál es la punta y cuál la raíz. Se conservan a temperatura ambiente en entorno seco y protegido de la luz.

Al ser el cabello una matriz biológica que va incorporando a su composición las sustancias químicas presentes en la sangre a medida que crece, y considerando que la velocidad de crecimiento es de 1 cm/mes, mediante el análisis del segmento proximal obtenido a las 3-5 semanas se podría detectar la sustancia administrada y/o su metabolito. La principal desventaja consiste en las ba-

jas concentraciones que se pueden esperar tras la exposición a una única dosis del compuesto administrado.

Se podrán enviar además muestras no biológicas, como la bebida o el alimento sospechoso o la sustancia, si los aporta el paciente.

4. ASPECTOS MÉDICO-LEGALES

A continuación se detallan determinados aspectos médico-legales que resultan clave para completar el procedimiento de actuación de forma adecuada.

4.1. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

El procedimiento de obtención de muestras biológicas se realizará por parte del personal asistencial de Enfermería/Diplomado Universitario de Enfermería (DUE) de Urgencias. Previamente, el médico responsable debe obtener consentimiento informado por escrito del paciente y/o representante legal (ejemplo en el anexo 1) y entregar una hoja de información al paciente (ejemplo en el anexo 2) en la cual se le informa de que se custodiarán sus muestras durante un tiempo en espera de que denuncie a la Policía lo sucedido con intención de solicitar análisis toxicológico-forense.

4.2. PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA SOBRE MUESTRAS BIOLÓGICAS

El personal encargado de “abrir la nevera” para custodiar las muestras biológicas será avisado por el personal asistencial implicado en el caso, médico o de Enfermería, con intención de firmar entre todos un documento de cadena de custodia (ejemplo en el anexo 3) con información relevante del caso que se adjunta junto a las muestras.

En dicha nevera se almacenan las muestras biológicas recogidas correctamente embaladas y acondicionadas en un contenedor siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Justicia (Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo) para mantener la uniformidad de recogida, embalaje, almacenaje y transporte conforme a la cadena de custodia.

Una copia queda en el Servicio de Urgencias (SU) y otra se le entregará a la persona a la que se entreguen las muestras tras cumplimentar el apartado de recibí con su identificación correspondiente. La entrega se puede realizar en el SU a petición judicial (no a un agente de la autoridad si carece de la correspondiente autorización) o en el laboratorio externo encargado de realizar el análisis mediante vehículo autorizado. La tercera copia se enviará por correo interno al gestor de casos de SQ.

4.3. EMISIÓN DEL PARTE DE LESIONES

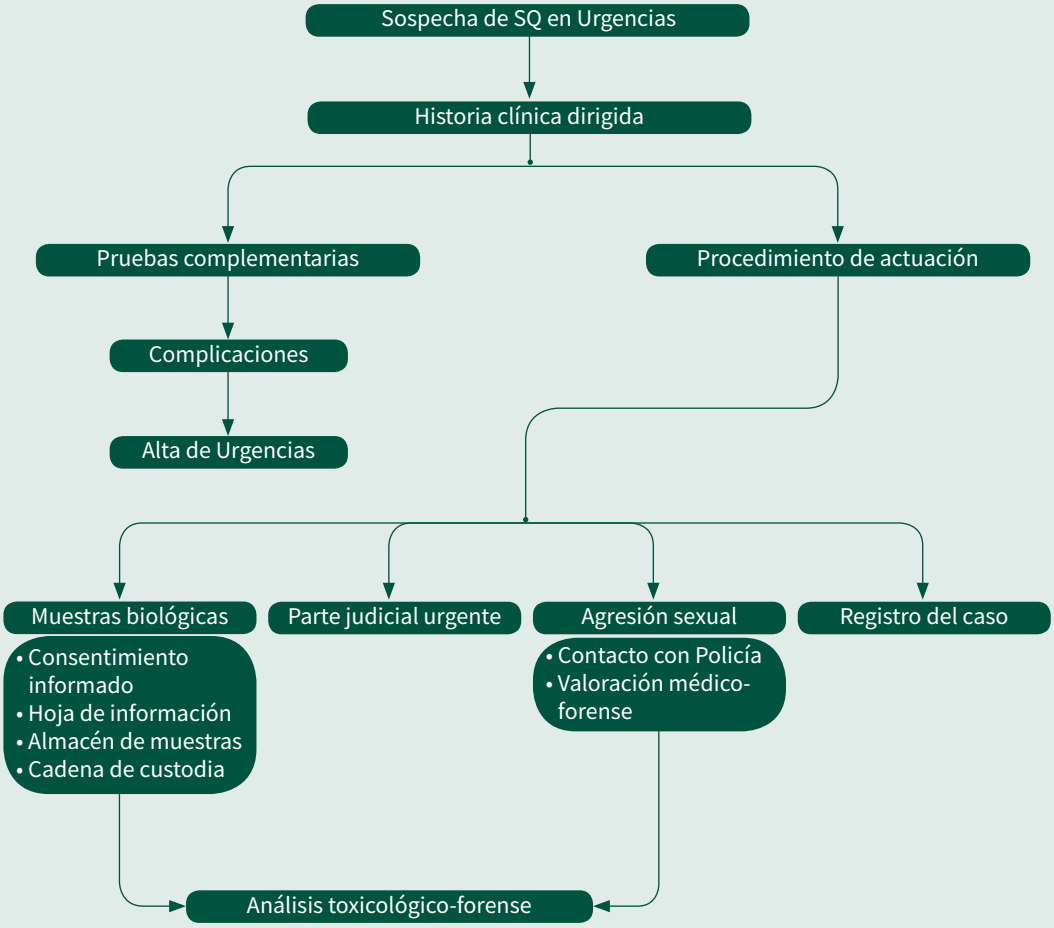
El médico responsable de la asistencia debe cumplimentar un parte de lesiones emitido por personal administrativo de Urgencias detallando la sospecha de SQ, la recogida de muestras biológicas y la posibilidad de agresión física o sexual.

El parte de lesiones es un documento de carácter médico-legal que debe enviarse a la mayor brevedad al Juzgado de guardia. Es por lo tanto un documento indispensable para que se tomen medidas desde el ámbito judicial.

Puntos clave/recuerda

- En un paciente en el que se sospeche que se hayan empleado sustancias para una SQ son fundamentales la anamnesis dirigida y la exploración física.
- Los síntomas que suelen referir las víctimas son amnesia completa o parcial, alteración del comportamiento o la conducta, confusión, somnolencia, agitación o alucinaciones, desinhibición, mareo, resaca desproporcionada o pérdida del conocimiento.
- Se pueden recoger muestras biológicas de sangre, orina y cabello dependiendo del tiempo que haya transcurrido. Hay que utilizar una cadena de custodia adecuada.
- Se debe entregar al paciente el consentimiento informado para recoger las muestras y un documento informativo de las medidas que se van a llevar a cabo.
- Debemos hacer un parte de lesiones.

ALGORITMO



SQ: sumisión química.

ANEXO 1

ESPACIO PARA
ETIQUETA IDENTIFICATIVA

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

Guía de detección clínica de la sumisión química

Ante la sospecha de una posible manipulación de su voluntad mediante la utilización de agentes químicos y considerando las responsabilidades de tipo penal que de dicho acto pudieran derivarse, el equipo asistencial que le atiende considera conveniente extraerle muestras biológicas de sangre y/u orina*.

Considerando las implicaciones legales derivadas del resultado de dichos análisis, es preciso contar con su autorización, tanto para la extracción de muestras, como para su remisión, por lo que rogamos suscriba el presente documento.

D/Dª _____

con DNI _____ , AUTORIZA la extracción de muestras biológicas (sangre y/u orina) para su remisión a un laboratorio externo, quien procederá a efectuar el análisis toxicológico de las mismas

Fdo.: Fecha y hora:

Firma del paciente o persona autorizada (tutor o representante legal)

☐ *Autorizo que mis resultados toxicológicos debidamente "anonimizados" puedan ser utilizados con fines de investigación.*

* Toda la información que facilite tiene carácter confidencial y se encuentra bajo el deber de secreto.

ANEXO 2

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EXTRACCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

Guía de detección clínica de la sumisión química

El Hospital _____ desarrolla un programa de detección clínica ante la sospecha de una posible situación de **Sumisión Química**.

Se conoce la "Sumisión Química" (SQ) como la utilización de agentes químicos para manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento con fines delictivos. Normalmente se utilizan sustancias psicoactivas que evitan que la víctima se encuentre en condiciones de prestar su consentimiento legal o de presentar resistencia a su atacante.

Para ello durante su asistencia sanitaria se le practicarán los exámenes necesarios para comprobar su estado de salud y puede ser necesario la obtención de muestras biológicas (sangre y/u orina) para poder detectar determinadas sustancias en su organismo. Estos análisis se realizan en laboratorios externos al hospital clínico (Laboratorio de la **Policía Científica** o **Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses**) y para ello activaremos una cadena de custodia adecuada.

Para que se pueda poner en marcha el envío de las muestras **Ud. debe hacer lo siguiente en cuanto le sea posible**:

1. **Poner la oportuna denuncia en la Comisaría de Policía.**
2. **Informar en la propia comisaría que el Hospital _____ _____ tiene sus muestras biológicas a disposición de los cuerpos de seguridad del estado.**

El hospital guardará sus muestras **durante 90 días**, tras ese periodo si no se ha iniciado **atestado policial o diligencia judicial** alguna, se destruirán desactivando con ello la cadena de custodia.

Esperamos su colaboración y una pronta recuperación.

ANEXO 3

DOCUMENTO DE CADENA DE CUSTODIA PARA MUESTRAS SOSPECHOSAS DE SUMISIÓN QUÍMICA

Guía de detección clínica de la sumisión química

Datos del paciente

1º APELLIDO .....

2º APELLIDO .....

NOMBRE ..... FECHA NAC. .....

Nº HISTORIA .....

ESPACIO PARA
ETIQUETA IDENTIFICATIVA

MUESTRAS EXTRAÍDAS: ☐ **Sangre** ☐ **Orina**

Posible etiología de la intoxicación .....

.....

.....

.....

Tiempo transcurrido desde la intoxicación: .....

La ***toma*** de muestras se ha realizado el día ..... a las .....

y han sido extraídas por DUE: .....

Las muestras han sido ***envasadas*** y almacenadas por Supervisora: .....

Se hace ***entrega*** de las muestras a: .....

Procedimiento judicial/atestado número: .....

El médico

Firmado en Madrid a .....